

Examen fédéral 2025 - J2

VD-GE-FR

👉 Pour chaque question :

- Vous pouvez indiquer si elle est **complète ou incomplète**.
- Vous pouvez préciser **le Type A/K'/Déroulant ou suivie**
- Vous pouvez préciser **si votre réponse est sûre ou débattue**.

Merci :)

Q1: [Question complète/incomplète]

Quel est le diagnostic de ce pied degeu ?



- A. shimisnimikini
- B. Ononochiynolys
- C. onychorrhexix
- D. mycose ongle
- E. oh djadja
- F. Paraphymosis
- G. Leptospirose (sûr)

Réponse: aucune idee [Sûr] F? D?

Q2: [Question complète/incomplète]

ANCRAGE : Patiente de 22 ans qui tombe enceinte et qui souhaite savoir pourquoi sous contraception orale elle est tombée enceinte, elle a eu un traitement par rifampicine pour une tuberculose récemment

Cause : Rifampicine

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q3: Homme avec myosis, bradypnée, somnolent. Quel en est la cause ?

- 1) Heroïne
- 2) Cocaine
- 3) Amphétamines
- 4) Alcool
- 5) Cannabis

Réponse : A

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q4: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q5: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q6: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q7: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q8: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q9: [Question complète]

Femme, 35 ans, fumeuse (15 UPA), connue pour kystes rénaux. Asymétrie pupillaire au réveil, avec céphalées intenses et inhabituelles qui ont cessé. À l'examen, anisocorie, légère ptose et mydriase à G ainsi que diplopie au regard vers la droite..

Quel est le dx le plus probable ?

- A) tumeur cérébrale
- B) anévrisme artère communicante postérieure
- C) dissection carotidienne
- D) dissection vertébrale
- E) accident ischémique au niveau du pont

Réponse: [Sûre] B

Q10: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q11: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q12: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q13: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q14: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q15: [Question complète/incomplète]

Patiente de 63 ans est intubée et ventilée suite à un choc septique sur pneumonie à pneumocoques et traitée par antibiothérapie pendant 10-14j. Puis traitement par hydrocortisone pendant 9jours (je sais plus pq) Bonne amélioration initiale puis augmentation des ses besoins en oxygène et augmentation de sa fréquence respiratoire spontanée à 18 cycle par minute. Quel examen effectuer?

- A) Radio thorax
- B) CT thorax
- C) Lavage broncho-alveolaire
- D) ETO ? plus sûre de la proposition. C'était pas échocoeur genre ETT ?
- E) Biopsie pulmonaire par bronchoscopie

Réponse: A?[Sûre / Débattue]

Q16: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q17: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q18: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q19: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q20: Question complète

Femme de 30 ans, primipare, a accouché il y'a une semaine. Nourrit son enfant par allaitement uniquement. Vient consulter car apparition douleur mammaire. Au statut vous objectiviez une masse au quadrant supérieur externe, rougeâtre, la patiente est subfébrile. Qu'est ce qui est le plus approprié pour la suite de la prise en charge ?

- A) Mammographie
- B) Thé à la camomille
- C) Biopsie
- D) Continuer allaitement sur le sein non atteint uniquement
- E) Continuer allaitement, tirer le lait et refroidir le sein avec du froid toute les 2h

Réponse: E +1 batard un peu psk QSE c'est loca typique cancer (NON pas en 1 semaine)
Javoueeee

Q21: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q22: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q23: [Question complète/incomplète]

Enfant de 8 ans retrouvé inconscient dans une piscine, personne a vu le mécanisme. On le sort de leau. Que faire ?

- A. Heimlich
- B. Coup de poing precordial
- C. Bouche à bouche
- D. Défibrillation
- E. Massage cardiaque

Réponse: C [Sûre]

Q24: [Question complète/]

Patiente afghane de 26 ans qui se présente pour la première fois au cabinet du généraliste. Depuis l'enfance elle présente des épisodes fébriles (40°C max) qui durent 2-3 jours, toutes les 4-6 semaines avec douleurs abdominales diffusent et arthralgies généralisées. Asymptomatique entre les épisodes. Tante et cousine maternelle souffrent des même symptômes.

Quel est le diagnostic le plus probable?

- A) fièvre méditerranéenne familiale
- B) malaria
- C) Behçet
- D) porphyrie

E) drepanocytose

Réponse: A +1 [Sûre]

Q25: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q26: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q27: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q28: [Question complète/incomplète]

Pte de 68 ans, connue pour: asthme, DM2, a eu une égratignure au MID en faisant du jardinage (avec des rosiers). 3j plus tard la pte consulte son MT; son MID est enflé (littéralement ce mot), rouge et légèrement fébrile. Son MT l'hospit (pcq c'est un Tiiigre). Elle bénéficie d'une AB (pas précisé lequel). 30h plus tard (oui c'est précis mdr), la pte se plaint de fortes douleurs, nous MA à l'étage on arrive et on voit une peau couleur livide. 12h plus tard (mdr encore c'est précis) on remarque des crépitements à la palpation du MID et l'érythème s'est étendu jusqu'au genou. La pte est hémodynamiquement instable et est mise sous vasopresseur. Quelle est la prochaine étape.

- Frottis de plaie
- FSC
- ECG
- IRM MID
- Chirurgie et débridement

Réponse: Chir/Débridement (on aurait pu aussi lui envoyer de l'amykacine aussi mdr, mais pas avant les prélèvements profonds i guess)

Q29: [Question ancrage]

Petite fille de 6 ans vient aux urgences pour un mal de gorge qui s'est installé il y a 3 jours, avec un état fébrile 38.5°C et refuse de manger et de boire. Ce matin, elle bavait beaucoup et sa mère a remarqué que sa voix avait changé.

Contre quel pathogène doit on vérifier la vaccination?

- A. Strepto pneumoniae
- B. Coxellia Burnetti
- C. Hémophilus Influenzae type B
- D. Mycoplasmos tuberculosis
- E. Bordetella pertussis

Réponse: C [Sûre] +1

Q30: [Question complète/incomplète]

Homme de 23 ans, qui consulte en raison de faiblesse et des paresthésies dans les jambes. Anamnèse sans particularité à l'exception d'une infection gastro-intestinale 2 semaines auparavant. Abolition des réflexes patellaires et achilliens. Force m3 aux membres inférieurs.

Quel examen pour confirmer le diagnostic?

- A) Irm lombaire
- B) Irm crânien
- C) Ponction lombaire
- D) ENMG
- E) Détermination de la neostigmine

Réponse: C (sûre)

Q31: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q32: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q33: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q34: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q35: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q36: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q37: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q38: [Question complète]

Une patiente de 35 ans enceinte à 22 semaines d'aménorrhée, sans antécédents particulier, qui présente une fatigue nouvelle sans autre symptôme. Elle est afebrile à 36.7 C, normotendue à 122/77, normocarde à 67bpm.

Hb 112

Thrombocytes 115

Reste (FSC + crase + tests hepatiques + LDH + bili) Normaux

A. syndrome myelodysplasique

B. HELPP

C. Hemophilie acquise spontannée

D. Thrombocytopenie gestationnelle

E. Syndrome anticorps antiphospholipides

Réponse: [D - Sûre]

Q39: [Question d'ancrage]

Un patient dépend à l'héroïne est diagnostiqué avec une schizophrénie. Le psychiatre lui prescrit donc de l'halopéridol et du diazépam. Trois jours après le début du traitement, il est admis aux urgences avec des troubles de la marche et des crampes de la langue et de la gorge. Que faut-il injecter d'urgence ?

- A) Anti-cholinergique
- B) Lorazépam
- C) Naloxone
- D) Atropine

Réponse: A [Sûre] → L'halopéridol peut induire des symptômes extrapyramidaux dont des dystonies aiguës, le traitement en aigu consiste en des anticholinergiques qui diminuent l'hyperactivité cholinergique du SNC causée par les symptômes extrapyramidaux

Q40: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q41: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q42: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q43: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q44: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q45: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q46: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q47: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q48: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q49: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q50: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q51: Patient de 70 ans, hospitalisé pour un accident ischémique transitoire (AIT), subit un US doppler des carotides. Soudainement, il perd connaissance. Il se réveille après un minute et redevient rapidement orienté. L'examen clinique neurologique est normal. L'examen cardio-vasculaire également. L'US doppler des carotides ne retrouvent rien de particulier.

Il s'agit de :

- A. crises d'épilepsie
- B. syndrome du sinus carotidien
- C. crise hypertensive
- D. dysrégulation orthostatique
- E. accident ischémique transitoire

Réponse B + 1

Q52: [Question complète]

Patiente de 76 ans qui consulte durant un mois de juillet particulièrement chaud pour des douleur et faiblesse de jambes. Elle est connue pour un diabète une hypertension artérielle

et un surpoids(bmi à 34). Elle prend depuis deux ans : amlodipine thiazide enalapril metformine et anti sgl2. Vous voyez sur la photo : œdème bilatéral retrouvé sur Google

Quel traitement met en cause ces symptômes :

A amlodipine

B enalapril

C Metformine

D anti sgl2

E thiazide

Réponse: A [Sûre] + 1

Q53: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q54: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q55: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q56: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q57: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q58: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q59: [Question complète/incomplète]

Patiente hospitalisée dans une chambre à 2 dans le cadre d'un cancer. Développe une légionellose après 10 jours d'hospitalisation.

Quelle prophylaxie ?

- A) Isoler la patiente
- B) Traiter préventivement la voisine
- C) Tester l'eau de la chambre pour la présence de légionnelle
- D) Recherche de légionnelle par Frottis du col de la voisine

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q60: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q61: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q62: [Question incomplète]

Femme de 35 ans, céphalée inhabituelle mais mtn ça va mieux. Elle a une ptose et mydriase à droite connue pour kystes rénaux. diagnostic ?

- A) AVC du pont
- B) anévrisme a. communicante postérieur
- C) AIT
- D) dissection carotide

Réponse: B [Sûre] ah zut je crois que j'ai retenu la mauvaise question

Q63: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q64: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q65: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q66: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q67: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q68: [Question incomplète]

Un patient de 34 ans, diagnostiqué d'une infection au VIH il y a 2 mois suite à une infection rétrovirale aiguë. Il rapporte avoir eu de multiples partenaires sexuels. Les tests de dépistage (il y avait le détail je me souviens plus) au VIH sont positifs. Le taux initial de CD4+ est de 515 copies/ml (normal : >500/ml) et le nombre de copies d'ARN du VIH est de 2'300'000. Le test génétique de résistance du VIH aux rétroviraux est négatif.

Quelle est la prochaine étape dans la prise en charge de ce patient ?

- A. Test phénotypique de résistance aux rétroviraux
- B. Refaire les tests de dépistage
- C. Mesure des antigènes anti-cryptococciques
- D. Débuter le traitement antirétroviraux
- E. Doser le taux de CD4+ dans 3 mois

Réponse: D+1 [Débattue]

Q69: [Question incomplète]

Homme jeune qui a des lésions prurigineuses ayant commencé au niveau des fesses, puis s'étant réparti entre les doigts, sur le tronc. Bonne santé habituelle. Il est masseur. Lésions en virgule, ...

Photo : des fesses avec des petites plaques érythémateuses.

Quel est le diagnostic ?

- Gale

- Eczema de contact disséminé
-

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q70: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q71: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q72: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q73: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q74: un patient de 77 ans est hospitalisé après un AVC ischémique à gauche. Il a bénéficié d'une thrombolyse. Actuellement il a toujours un hémisyndrome à droite, en amélioration, et un glasgow fluctuant entre 10 et 14. Il a été extubé il y a 24h. On vous appelle dans son box car la respiration sur le moniteur est anormale.

- A. Réparation de Kussmaul
- B. Respiration de Cheynes- stokes
- C. Apnées du sommeil
- D. Physiologique après extubation
- E. Respiration atonique (Biot)

(add image d'un moniteur avec respiration de Cheynes-Stokes?)

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q75: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q76: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q77: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q78: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q79: [Question complète/incomplète]

Mère qui vient au contrôle de routine avec son fils de 4 mois. Pas de plainte particulière mais elle mentionne que son fils rejette en fin de tété le lait ingéré. Croissance dans le 75e percentile et poids dans le 50e percentile (pas de cassure de courbe). Examen clinique dans la norme.

Quelle est la prochaine étape:

A. pH métrie

B. Transit osophago intestinal

C. US abdo

D. Endoscopie gastro-duodenale

E. Pas d'examen complémentaire

Réponse: E [Sûre]

Q80: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q81: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q82: [Question complète/incomplète]

Une femme qui présente une maladie de Basedow, doit se faire opérer de la thyroïde. En post-op elle présente une voix soufflée, et une dysphonie. Quel nerf est lésé ?

A. vague

B. Accessoire

C. Hypoglosse

D. Glossopharyngien

E. Laryngé récurrent

Réponse: E

Q83: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q84: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q85: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q86: [Question complète]

Femme de 65 ans qui consulte aux urgences en raison d'un ictère depuis 5 jours. De plus, elle rapporte avoir perdu 10% de son poids corporel lors du dernier mois. À l'examen clinique, on palpe une masse indolore en hypochondre droit qui est plus perceptible à l'inspiration profonde. Au laboratoire vous avez:

FSC normale

TP normal

ASAT 280

ALAT 250

Bilirubine totale à 185

À l'échographie vous observez une vésicule biliaire avec un volume augmenté, correspondant probablement à la masse palpée.

Quelle étiologie explique le mieux cet élargissement.

- A. Cholecystite
- B. Migration biliaire
- C. Syndrome de Mirizzi
- D. Tumeur de Klatskin (cholangiocarcinome extrahepatique)
- E. Tumeur du pancréas

Réponse: E [**Sûre** / Débattue]

Pour moi c'est D pour cette question +1

Q87: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q88: [Question complète]

Femme de 67 ans, qui présente une BAV soudaine unilatéral. Depuis quelques semaines se sent fatiguée et a des maux de tête avec une légère fièvre. Quel est l'examen le plus recommandé?

- vitesse de sédimentation
- IRM cérébral
- Radio thoracique
- Écho cardio

Réponse: [Sûre / Débattue] vs ? + 2

Q89: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q90: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q91: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q92: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q93: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q94: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q95: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q96: [Question complète]

Des parents amènent leur enfant de 22 mois aux urgences. Ils l'ont retrouvé inconscient dans le lit avec le visage bleu. Il a présenté des mouvements rythmés des bras et des jambes. L'épisode a duré 3-4 min. L'enfant est resté somnolent 20 min après. Autrement, il est en bonne santé habituel. Aux urgences vous remarquez que l'enfant présente une légère baisse de l'état général avec une température à 39,7°. Le reste de l'examen neuro est dans la norme.

Votre diagnostic :

- A) Convulsion fébrile simple
- B) Absence épileptique
- C) Spasme du sanglot
- D) Crise tonico-clonique généralisée
- E) Convulsion sur méningo-encéphalite

Réponse : A [Sûre]

Q97: [Question complète/incomplète]

Patiente de 83 ans connue pour HTA, consommation excessive d'alcool. Elle boit 2 verres par jour de vin. Elle se présente actuellement pour une distension abdominale qui l'incoforte. Elle vous dit qu'elle a perdu 4kg, malgré une augmentation du périmètre abdo. Au labo on retrouve une FSC normal, INR 1.4, albumine normal, bili un peu augmenté, ALAT et ASAT directement augmenté. Pas d'astérix. US abdominal montre un épanchement dans le récessus de morisson. Quel diagnostic faites-vous ?

- A) Scintigraphie
- B) Paracentèse
- C) Fibroscan

D) PET-CT

E) IRM

Réponse: B [Sûre / Débattue]

Q98: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q99: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q100: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q101: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q102: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

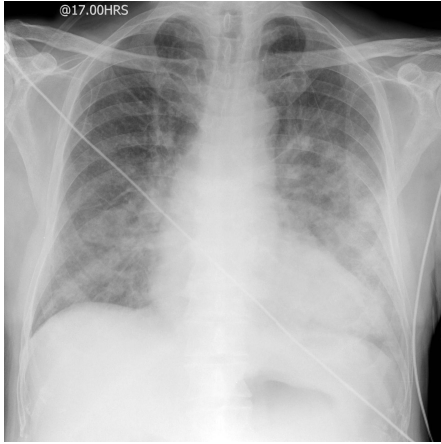
Q103: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q104: [Question complète]

Patiente de 84 ans connue pour une HTA traitée par enalapril et une FA anticoagulée qui vient aux urgences pour une dyspnée d'apparition subite sur la nuit, associée à une toux. La patiente fume 1,2 paquets par jour depuis 17 ans ainsi que deux verres de whisky. A son arrivée aux urgences, la patiente est polypnéique à 22/min, TA 178/110; FC 108, T 37,8°C.

L'auscultation pulmonaire retrouve des crépitants sur les deux plages pulmonaires en prédominance à gauche, des signes de tirages. L'auscultation cardiaque est sans particularité. L'ECG est normal. C'est le premier jour de l'interne qui est en panique et qui vous (stagiaire de 4ème année) demande ce que vous voyez à la radio:



- A) Embolie pulmonaire
- B) Pneumonie
- C) Décompensation BPCO
- D) OAP
- E) Bronchite aiguë

Réponse: D [Sûre]

Q105: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q106: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q107: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q108: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q109: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q110: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q111: [Question complète/incomplète]

Endocardie

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q112: [Question complète]

Patient de 67 ans qui consulte pour une douleur cervicale progressive depuis plusieurs mois, péjorée le soir. Il remarque un tremblement de sa main gauche. Il rapporte également une fatigue et une thymie basse mais ne sait pas pourquoi.

A l'examen clinique, on retrouve une rigidité de la nuque et de la main gauche. Le patient présente un tremor de repos de sa main gauche, ainsi qu'un léger tremor d'intention des 2 mains. Le tapping des doigts est diminué. Le reste de l'examen clinique est sans particularités.

Quel diagnostic est le plus probable ? (menu déroulant)

Réponse: [Sûre / Débattue] Parkinson

Q113: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q114: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q115: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q116: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q117: [Question complète] (3eme partie vignette cirrhose et CHC)

(K') Une hépatectomie avec résection du segment 6 est réalisée. On retrouve un CHC de 2.3 cm avec des marges suffisantes. 2 ans plus tard, deux nouvelles lésions de 1,5 et 1,8 cm sont découvertes. Il n'y a pas de métastases. La patiente est toujours sevrée de l'alcool. Au Tumor Board, la transplantation hépatique est discutée. Quelles seraient chez cette patiente les contre-indications à la transplantation ?

- A. La durée du sevrage alcoolique
- B. L'antécédent de chirurgie hépatique
- C. Le nombre de lésions
- D. La taille de la plus grande lésion

Réponse: -/-/- [Sûre]

Q118: [premiere partie vignette cirrhose]

Une femme de 52 ans consulte pour des douleurs abdominales chroniques et une sensation de gonflement de l'abdomen. Autrement pas d'autre plainte.

Elle consomme environ 5 unités d'alcool par jour depuis plusieurs années. À l'examen clinique, l'abdomen est distendu, avec une matité déclive des flancs. L'US que vous réalisez montre l'image suivante :



(Pas trouvé mieux ...mais en gros image d'US avec liquide libre).

Au labo: transaminases élevée, ggt et pal aussi, hypoalbuminémie, bili totale haute, INR haut

Quel examen réaliser? (Pas sûre des propositions non plus désolé)

- A. IRM hépatique
- B. Fibroscan (élastographie hépatique)
- C. Ponction d'ascite
- D. Dosage des marqueurs viraux hépatiques
- E. Endoscopie digestive haute

Réponse: C [Sûre]

Q119: [Question complète/incomplète]

Réponse: [Sûre / Débattue]

Q115.3: [Question complète]

Le diagnostic de maladie coeliaque est retenu. Le pédiatre explique aux parents l'utilité d'un régime d'éviction du gluten.

En cas de non-respect du régime, quelle est la complication possible dans la liste de diagnostics suivants ?

- A. Pancréatite chronique
- B. Maladie de Crohn
- C. Hypothyroïdie
- D. Sténoses du tractus digestif
- E. Lymphome intestinal

Réponse: Lymphome intestinal [Incertaine] → Selon ChatGPT, l'hypothyroïdie est une maladie associée (car maladie auto-immune) mais ce n'est pas une complication du non-respect du régime. Apparemment le lymphome intestinal surviendrait en raison d'inflammation chronique de la muqueuse intestinale.

Questions en vrac (mettez tout ce dont vous vous souvenez, ça nous a beaucoup aidé pour le J1 !):

- 1) Toxidrome anticholinergique → réponse présumée : physostigmine
- 2) K' Syndrome sérotoninergique sur tentamen à la sertraline → réponse présumée : agitation (vrai), hyporéflexie (faux), tachycardie (vrai) myoclonies (vrai)
- 3) Question dans la vignette de la transplantation de foie → réponse (sûre) : résection du segment 6
- 4) On veut faire validé un nouveau test en gynéco en le comparant au resultat des biopsie(GS). Calculez la specificité → réponse présumée : 80/100

a)

	Biopsie Pos	Biopsie neg
Test pos	72	20
Test neg	28	80

- 5) K' complications PID non-traitée (ANCRAGE) → réponse présumée : stérilité (vrai, pas sûr parce que c'est de l'infertilité), péri-hépatite (vrai), douleur pelvienne chronique (vrai), GEU (vrai)
- 6) Pt agé se brise la diaphyse huméral en chutant, aucune autre lésions, extension du poignet et des doigts impossible → réponse présumée : nerf radial
- 7) Pte plutôt jeune qui se plaint de BAV (avec correction 0.6 à D et 1.0 à G). Yeux sec, à la fluo on voit du vert bilat dans le tiers inférieur mdrrr ? en inféro temporale (wtf). Diminution de la vision du rouge à D. Yeux rouge, injecté et (chemosis ?) bialt. La patiente fait des insomnie et a perdu du poids involontairement réponse présumée :

orbitopathie endocrinienne (autres propositions : métastase orbitaire, fistule carotido-caverneuse,)

- 8) Meuf avec signes de méningite, que faire en premier → réponse présumée :
hémocultures
a) CT cérébral
b) Hémocultures
c) PL
d) ?
- 9) Meuf enceinte de jumeaux à 22 SA, douleurs au bas-ventre. Pas de saignements ni pertes liquidiennes. Quel diagnostic suspecté ? → réponse présumée : menace?
a) Décollement placentaire
b) Menace de fausse couche tardive
c) Colique néphrétique
d) ?
e) ?
- 10) Meuf qui a plein d'hématomes atraumatiques, post-chutes à répétition et suite à des accidents de sport. Photo avec des bon gros yeux au beurre noir. Que suspectez-vous ? → réponse présumée : violences conjugales
a) Coagulopathie
b) Violences conjugales
c) ?
d) ?
e) ?
- 11) Patiente connue pour BPCO à 15 UPA. Dyspnée et expectorations purulentes. Rx avec un énorme foyer. Quel diagnostic ? → réponse : jsp entre pneumonie et exacerbation de BPCO
- 12) Vignette coeliaquie → réponse sûre : dosage Ac anti-transglutaminase
- 13) Menu déroulant avec toxicomane avec drogues IV retrouvé par les polices en frissons, EF 38.9, status normal. Rx qui semblait normale et photo d'un doigt avec lésion de Janeway → réponse présumée : endocardite aiguë et subaiguë
- 14) Mec ou meuf sous lithium ,polydypsie + tremblements → réponse présumée : diabète insipide néphrogénique sur lithium
- 15) Chirurgie dentaire chez patiente avec insuffisance mitrale sans prolapsus, quelle prophylaxie ? → réponse présumée : aucune prophylaxie
a) Amoxicilline 2g une dose unique
b) Amoxicilline 500mg 1x avant et 1x après opération
c) ?
d) ?
e) Aucune prophylaxie
- 16) Photo d'une bouche dégueu chez une patiente sous zolédronate → réponse présumée : nécrose mandibulaire
- 17) Photo vulve avec vésicules périnéales, qui apparaissent 3-4x par an → réponse présumée : herpès (y avait aussi lichen scléreux dans les propositions)

- 18) Patiente de 84 ans retrouvée dans son appart par sa nièce, elle appelle 144. On arrive 30min plus tard, la nièce n'a rien fait pendant ce temps. A l'examen, dame en mydriase bilatérale, absence de pouls et de respiration, qu'est-ce qu'il faut faire ? → réponse présumée → chercher signes de mort certaine
- a) Massage cardiaque
 - b) Adrénaline
 - c) Défibrillation
 - d)
 - e) ?
 - f) Chercher des signes de mort certaine
- 19) Patient retrouvé sans pouls et sans respiration pendant la vignette. Dans quel ordre faut-il faire les choses ? → réponse présumée : aucune idée entre masser puis réa ou réa puis masser (dans la vraie vie on fait les 2 en même temps vu qu'on est plusieurs pendant la visite...) -> B
- a) Massage cardiaque, insufflations, appel à la réa
 - b) Appel à la réa, massage cardiaque, insufflations
 - c) Massage cardiaque, appel à la réa, insufflations
 - d) Insufflations, massage cardiaque, appel à la réa
 - e) Insufflations, appel à la réa, massage cardiaque
- 20) Scanner d'une énorme dissection aortique haha → réponse sûre : dissection aortique
- a) Dissection aortique
 - b) Pneumothorax
 - c) Pneumonie
 - d) ?
 - e) ?
- 21) Rx de hanche d'un patient sous pred avec douleurs à l'aine → réponse présumée : nécrose de la tête fémorale, arthrite
- 22) Vieille avec MID en rotation externe et raccourci. Qu'est-ce qu'on doit faire ? → réponse présumée : Rx hanche D de face et profil
- a) Rx hanche D de face et profil
 - b) Rx hanche G de face et profil et Rx hanche D de face et profil
 - c) ?
 - d) ?
 - e) ?
- 23) Meuf avec syndrome grippal. Au status on voit une angine avec des dépôts grisâtres. Mise sous Amoxicilline (bah bravo), développe rash cutané au tronc (photo). Quel germe en cause ? → réponse présumée : EBV
- a) CMV
 - b) EBV
 - c) Treponema pallidum
 - d) ?
 - e) ?

- 24) Enfant avec douleur humérale → réponse présumée : kyste osseux ; y avait une petite réaction périostée non ?
- a) Kyste osseux
 - b) Sarcome d'Ewing
 - c) Ostéosarcome
 - d) Arthrite de hanche
 - e) ?
- 25) Maman tire le bras de sa fille à l'aire de jeux. Que faire ? → réponse présumée : Rx du bras / je dirais plutôt réduction sans radio
- 26) Mec avec goutte, acide urique élevé mais asymptomatique). Je crois qu'il a eu plusieurs crises de gouttes dans le passé et des tophi. Que faire ? → réponse présumée : allopurinol (vraiment pas sûr si on peut commencer parce qu'il est asymptomatique mais a quand même une hyperuricémie)
- a) Commencer allopurinol
 - b) Commencer autre médoc
 - c) Un truc du style injecter qqch dans les tophi
 - d) ?
 - e) ?
- 27) Vidéo d'un scanner thoracique avec monstre pneumothorax → réponse présumée : poser un drain thoracique
- 28) Question d'ancrage avec trépanation de l'ongle
- 29) Meuf varices oesophagiennes. A arrêté son traitement de b-bloquant. Varices qui saignent, hypotendue. Que faire ?
- a) Ad remplissage par cristalloïdes
 - b) Endoscopie
 - c) ?
 - d) ?
 - e) ?
- 30) Femme enceinte 40 SA, fœtus en position transverse. Que faire ? → réponse présumée : césarienne
- 31) Jeune partie en Lybie avec sa copine pour construire puits d'eau. Revient ictérique et en mauvais état général. Quel diagnostic ? → réponse présumée : hépatite A
- a) Hépatite A
 - b) Schistosomiase
 - c) ?
 - d) ?
 - e) ?
- 32) Jeune fille de 13 ans avec gonalgies ? Violence verbale entre les parents depuis leur séparation il y a 1 an. Que faire ? → réponse présumée : TPPE vs consult avec les 3
- 33) Meuf avec syncope convulsivante (mouvements plutôt pseudo-convulsifs) et amnésie rétrograde (plutôt amnésie lacunaire) → réponse présumée : EEG elle était hypotendue plutôt schellong
- 34) Question d'ancrage sur légionella → réponse sûre : chercher légionelle dans l'eau

- 35) K' d'ancrage : patient auquel on a enlevé un cancer buccal avec métastases à 2 ganglions du même côté de la lésion. Le tumorboard suggère une radiothérapie. Quelles effets secondaires possibles sont à expliquer au patient ? → réponse présumée : +/-/+/+
- a) Mucite
 - b) Hypersialorrhée
 - c) Risque de caries
 - d) Lymphoedème cervical
- 36) Prurit anal. Où on doit chercher le parasite ? → réponse présumée : anus
- a) Sang
 - b) Selles
 - c) Anus
 - d) ?
 - e) ?
- 37) Parents en PLS parce que leur fille de 9 semaines fait que hurler et pleurer, et ce, depuis sa naissance.. Que faire ? → hospitalisation de répit ?
- 38) Gosse avec crise d'épilepsie, en état post-critique depuis 20min. Que faire ? → réponse présumée : diazepam intrarectal
- 39) TC frontal avec reconstruction CT 3D. Quel élément indique une chirurgie en urgence → réponse présumée : présence de B-transferrine ?
- 40) Homme de 50 ans, vient pour check-up. Quel examen de dépistage → réponse présumée : coloscopie
- 41) Patient vient pour asthénie et jsplus quoi mais rien qui indiquait de faire un stix et un sédiment. Ils ont fait un stix et un sédiment qui retrouve une protéinurie. Quelle est la cause ? → réponse présumée : gammapathie monoclonale
- a) Syndrome néphrotique
 - b) Gammapathie monoclonale
 - c) ?
 - d) Glomerulonephrite
 - e) ?
- 42) Radio de luxation du lunatum
- 43) Meuf qui va accoucher. On lui fait une péridurale, son bébé bradycarde. Pourquoi ? → réponse présumée : hypotension maternelle sur anesthésie
- 44) Rx du genou. Quelles lésions sont évocatrices d'une arthropathie inflammatoire et non mécanique ? → réponse présumée : érosions marginales ?
- a) Érosions marginales
 - b) Un autre mot pour dire ostéophytes
 - c) Pincement articulaire
 - d) ?
 - e) ?
- 45) Patient en crise hypertensive (180/ ? mmHg) chez MT, reprise de la tension 3x. Quelle PEC ? → réponse présumée : antihypertenseur PO ? vs prise de tension sur 48h et se revoir dans 2j

46) Meuf avec mal de tête et devient somnolente et confuse sans signes méningés →
réponse présumée : encéphalite ?